一线去化疗证据强化，关注套细胞淋巴瘤新方案审批与放量

2026 年 ASH 会议前瞻

医药生物行业专题研究 | 2026 年 11 月 10 日

投资要点

核心判断：MANGROVE 三期研究的摘要主要分析显示，泽布替尼联合利妥昔单抗（ZR）较苯达莫司汀联合利妥昔单抗（BR）显著改善既往未治疗套细胞淋巴瘤（MCL）患者的无进展生存期（PFS），为一线去化疗方案提供随机对照证据；美国 FDA 已授予补充新药申请优先审评，欧盟与中国亦已进入申报审评流程。若获批，商业兑现取决于可治疗人群边界、持续治疗时间、实际净价和支付准入。优先审评仅改变审评时限，不代表审评结论或获批保证。

证据进展：ASH 官网摘要披露 510 例入组、中位随访 44.1 个月，独立评审 PFS 风险比（HR）0.57；ZR 组中位 PFS 尚未达到，对照组 39.2 个月。4 年 PFS 率分别为 62.4% 和 46.2%。OS 在本次分析时仍不成熟，虽有数值趋势，尚不足以确认生存获益。

投资观察：泽布替尼已具备大体量全球销售基数。公司披露 2026 年第三季度 BRUKINSA 全球销售额约 14 亿美元，同比增长 34%；因此，一线 MCL 属于潜在新增适应症，不能与既有适应症销售混算。关注 12 月 13 日 ASH 全会正式展示是否更新疗效、安全性、患者报告结局及亚组数据，以及 FDA、EMA、NMPA 后续审评节点。

主要待验证条件：全会及后续随访确认获益稳健性；审评机构接受临床获益与风险证据；真实世界患者适用范围与临床路径清晰；长期 BTK 抑制剂暴露的耐受性和停药管理可接受；各市场医保、商业保险与定价支持放量。

一、行业事件与治疗需求

（一）一线治疗的核心人群与未满足需求

MCL 是成熟 B 细胞非霍奇金淋巴瘤亚型，患者以老年人为主，疾病生物学和临床过程存在较大异质性。低肿瘤负荷、无症状患者可在专科评估后观察；需要系统治疗者则按年龄、体能、移植适合度、TP53 状态、增殖指数和疾病风险分层。移植适合的年轻患者常采用强化免疫化疗及巩固策略；年长或不适合自体造血干细胞移植（ASCT）的患者，常见一线方案包括 BR 等免疫化疗。治疗选择并非单一路径，不能把全部新诊断患者视为同一可及市场。

传统免疫化疗可带来持续缓解，但烷化剂、细胞毒药物相关的骨髓抑制、感染及输注负担，对高龄或合并症患者尤其重要。BTK 抑制剂改变了复发难治 MCL 治疗格局；一线联合治疗进一步探索在保留疾病控制的同时减少化疗暴露。MANGROVE 的 ZR 方案前 6 个周期联合利妥昔单抗，之后继续口服泽布替尼至疾病进展或不能耐受；这不是固定疗程方案，意味着潜在治疗便利与长期暴露、累积成本和持续安全性需共同衡量。

（二）临床证据与全球销售之间的传导

该事件的商业逻辑可拆为四个连续环节：随机对照研究证实临床获益；监管机构认可适应症和用药标签；临床指南、医生与患者接受新方案；支付体系覆盖并形成持续用药。任何一环均可能延迟或压缩收入兑现。MCL 为相对罕见的血液肿瘤，单一适应症对公司收入影响需放在泽布替尼既有大基数中衡量，且不能将风险比直接换算为市场份额或销售增速。

二、MANGROVE 数据解读

（一）研究设计及入组边界

MANGROVE（BGB-3111-306；NCT04002297）是一项全球、多中心、开放标签、随机三期研究。510 例既往未治疗 MCL 患者按 1:1 分配至 ZR 组（257 例）和 BR 组（253 例）。入组年龄为 70 岁及以上，或 60 至未满 70 岁且不适合 ASCT；ECOG 体能状态为 0 至 2，并须有可测量病灶。ZR 组接受泽布替尼联合利妥昔单抗 6 个周期，随后泽布替尼单药直至进展；BR 组接受 6 个周期后观察。两组利妥昔单抗均为每月给药，共 6 次，未安排维持治疗。主要终点为独立评审委员会（IRC）评估 PFS。

该设计主要代表年长或不适合移植患者，不能直接外推至所有年轻、移植适合人群。开放标签可能影响部分评估行为，但主要终点由 IRC 评估。研究对照为 BR，而非当前所有地区和风险分层下的全部标准方案；治疗路径需结合本地指南及患者个体特征判断。

（二）疗效信号强，生存结论仍待成熟

ASH 摘要报告中位随访 44.1 个月。IRC 评估的 PFS HR 为 0.57（95% 置信区间 0.43 至 0.76，单侧 P<0.0001），ZR 组中位 PFS 尚未达到（95% 置信区间下限 56.5 个月，上限未估计），BR 组为 39.2 个月（95% 置信区间 33.5 至 55.7 个月）；4 年 PFS 率为 62.4% 和 46.2%。预设亚组包括高危 MIPI、母细胞样/多形性组织学、Ki-67 不低于 30% 及 TP53 突变，摘要称获益方向一致。亚组样本较小，仍需正式报告中的交互作用检验、置信区间和缺失数据说明。

OS HR 为 0.71（95% 置信区间 0.51 至 0.99，单侧 P=0.0222），4 年 OS 率为 75.1%

和 67.6%，但 OS 仍被研究者界定为不成熟。对照组后续接受抗癌治疗者中 88.2% 使用过 BTK 抑制剂，这可能影响组间 OS 差异解释。当前可支持“PFS 改善且观察到 OS 数值趋势”，不能写成“已证实延长总生存”。

（三）安全性需按时间窗口理解

安全性结果取决于观察时间和治疗暴露。摘要报告，从开始治疗至疾病进展或开始新抗癌治疗的安全性报告期内，ZR 与 BR 组 ≥3 级不良事件发生率分别为 75.0% 和 73.6%，严重不良事件分别为 56.6% 和 46.0%，导致死亡的不良事件分别为 9.0% 和 8.8%。而仅观察前 6 个月诱导期时，≥3 级不良事件为 39.8% 和 58.4%，严重不良事件为 19.1% 和 23.6%。两种窗口回答的问题不同；鉴于 ZR 组持续用药、BR 组完成 6 周期后观察，累计发生率不宜被解读为疗程等长的直接毒性比较。

按每 100 人月暴露校正后，摘要列示感染、嗜中性粒细胞减少、贫血、血小板减少、房颤/房扑和高血压等事件率在 ZR 组较低；其中感染 4.69 比 7.80，嗜中性粒细胞减少 0.78 比 9.14。暴露校正率描述单位时间事件频率，不能取代患者层面的累计风险、停药率、剂量调整、出血及心血管事件细节。ZR 长期持续治疗的依从性、停药原因及高龄合并症患者获益风险，仍是正式展示和上市后监测的重点。

（四）摘要与 ASH 正式展示的时点差异

截至 2026 年 11 月 10 日，ASH 在线摘要已经公开上述预设主要分析结果；它并非仅公布 HR 的简短标题，而包含研究设计、主要疗效、安全性和 OS 成熟度。企业称完整研究结果将在 2026 年 12 月 13 日 ASH 全会报告。现阶段不应预写尚未公开的更新数字。后续应逐项核对数据截止日期、随访时长、PFS 评审口径、OS 事件数、严重不良事件分项、停药率、生活质量和关键亚组；若数据截止时间或分析集不同，应明确标注为更新分析，避免将摘要与现场展示拼接成同一数据截点。

三、竞争格局与审批路径

（一）竞争重点是治疗策略和证据可比性

一线 MCL 并非空白市场。美国 FDA 已于 2025 年批准阿卡替尼联合 BR 用于不适合 ASCT 的初治患者，ECHO 三期研究以 BR 为对照，中位随访 49.8 个月时 PFS HR 为 0.73；但该方案保留苯达莫司汀化疗。SHINE 研究评估伊布替尼联合 BR，TRIANGLE 则在较年轻、适合强化治疗的患者中评估含伊布替尼的免疫化疗和移植策略。另有无化疗双联或三联的早期研究，但证据等级和患者范围不同。跨试验在入组年龄、风险分层、对照方案、随访、后续治疗及终点评估方面有差异，不能据 HR、缓解率或单臂 ORR 作疗效排名。

表 1 一线 MCL 主要证据与治疗路径核对

方案/研究	人群与阶段	关键证据	研判边界
ZR / MANGROVE	年长或不适合 ASCT；全球随机三期	510 例；中位随访 44.1 个月；PFS HR 0.57；4 年 PFS 62.4% vs 46.2%	无化疗；持续泽布替尼；OS 未成熟；未获批一线
阿卡替尼 +BR / ECHO	初治且不适合 ASCT；随机三期，FDA 已批	598 例；中位随访 49.8 个月；PFS HR 0.73	仍含化疗；不同研究不可直接比较
伊布替尼 +BR / SHINE	年长初治患者；随机三期	支持 BTKi 加入 BR 的疾病控制证据	化疗与 BTKi 暴露并存；需结合当期指南及安全性
含伊布替尼强化方案 / TRIANGLE	较年轻、适合强化治疗；随机三期	比较强化免疫化疗、移植及伊布替尼策略	目标人群与 MANGROVE 不同
ZR 无化疗组合 / II 期探索	初治患者；单臂或小样本研究	可提供可行性与初步活性信号	不等同随机三期确证证据

注：表中各研究来自不同试验，不构成头对头疗效比较。BR 为苯达莫司汀联合利妥昔单抗；ASCT 为自体造血干细胞移植；HR 为风险比。资料来源：ASH 摘要、FDA 及公开临床研究。

（二）监管进度从申报受理走向审评结论

美国 FDA 于 11 月 4 日宣布受理泽布替尼联合利妥昔单抗用于成人初治 MCL 的补充新药申请并给予优先审评。公司同时披露已向 EMA 递交申请，并获中国国家药品监督管理局药品审评中心（CDE）受理；申报均基于 MANGROVE。三个市场的受理状态不应被描述为上市许可。应继续跟踪 FDA 审评完成日期及标签范围、EMA 审评意见与欧盟委员会决定、NMPA 技术审评及批准公告。企业披露日本一线 MCL 申报预计于 2026 年第四季度，属计划节点而非已完成事项。

（三）竞争优势取决于标签和实际治疗定位

若监管认可 ZR 用于所研究的初治患者，差异化将来自化疗规避、口服持续治疗，以及随机三期头对头比较 BR 所提供的证据。但标签最终范围、指南推荐等级、对不同风险亚组的定位，以及医生对长期口服 BTKi 的接受度，均影响实际渗透。既有 BTKi、含 BTKi 免疫化疗、固定疗程组合与细胞治疗在不同疾病阶段和患者中的角色会并存；新适应症放量更可能是患者分层后的治疗选择重构，而非对所有方案的整体替代。

四、业绩与估值验证

（一）销售基数与新增适应症拆分

BeOne 披露 BRUKINSA 2026 年第三季度全球销售额为 14 亿美元，同比增长 34%；美国销售额为 10 亿美元。公司 2026 全年总收入指引上调至 69 亿至 70 亿美元，但总收入指引同时包含其他产品和业务，不应作为一线 MCL 销售基线。公司未单独披露 MCL 适应症销售额，因此适应症增量需独立建模，并与现有 CLL/SLL、WM、复发难治 MCL 等适应症区分。

（二）收入敏感性：用患者覆盖和持续时间拆解

在尚无公开目标市场净价、获批标签及真实世界治疗时长的情况下，不宜给出单点销售预测。可用以下公式做滚动校验：某年度新增销售额约等于“符合标签的年度新治疗患者数 × 采用 ZR 比例 × 平均治疗年限 × 年均净销售额/患者”。以下仅为假设情景，每年以 1,000 名符合标签的新治疗患者为测算单位，反映稳定治疗队列中的年化销售规模；它不是疾病流行病学估算、公司指引或峰值销售预测。高渗透情景也没有计入患者支付能力及同类治疗竞争的约束。

表 2 一线 MCL 新增销售情景敏感性（每年 1,000 名符合标签患者）

情景	ZR 采用率	平均用药时间	年均净销售额/患者	稳态年化增量
谨慎	20%	1.5 年	7 万美元	2,100 万美元
基准	40%	2.0 年	10 万美元	8,000 万美元
积极	60%	2.5 年	13 万美元	1.95 亿美元

注：公式为年度患者数 × 采用率 × 平均用药年限 × 年均净销售额/患者；表内参数为分析情景假设，非公司预测或现行价格。结果未计汇率、停药、折扣、税费、地区销售分成、患者跨期治疗队列爬坡及新适应症间替代。若按单一新患者队列首年计算，情景收入分别约为 420 万、2,000 万和 7,800 万美元；稳态数值反映多个年度治疗队列重叠。

公司的销售兑现应按三个阶段观察：获批后首先是适用患者中使用率和启动治疗人数；随后是平均用药持续时间、剂量调整与停药；最终体现为净价、报销覆盖和各市场销售分布。由于泽布替尼一线方案采用持续治疗，较长 PFS 一方面可能扩大在治患者存量，另一方面也提高累计药费和长期安全性审视的重要性。价格折扣、保险准入、患者援助和竞争性方案可能压低模型中的净价或采用率。

表 3 临床证据—监管节点—销售假设核对表

链条节点	已有事实	下一步核对项	当前状态
临床证据	MANGROVE 随机三期；PFS HR 0.57；摘要中位随访 44.1 个月	ASH 正式展示更新截点、OS 成熟度、安全性分项、生活质量、亚组	PFS 阳性；OS 未成熟
美国监管	sNDA 获 FDA 优先审评	审评结论、标签适用人群、剂量和警示	审评中
欧洲监管	EMA 已受理申报	审评意见、欧盟批准决定和上市时间	审评中
中国监管	CDE 已受理申报	技术审评结论、批准范围、医保及院内准入	审评中
商业采用	2026Q3 BRUKINSA 全球销售约 14 亿美元	新治疗患者、渗透率、用药时长、净价及支付覆盖	尚无一线 MCL 独立销售额

注：监管状态截至 2026 年 11 月 10 日，依据企业公告；受理和优先审评均不代表批准。收入预测只应在适应症、价格及覆盖率信息逐步明确后滚动更新。

五、投资策略与风险提示

（一）投资策略

建议将该事件视为泽布替尼全球化商业兑现的边际跟踪因素，而非独立的估值锚。临床端关注 ASH 正式展示对摘要主要结果的补充及 OS 成熟进度；监管端逐市场区分受理、审评、批准和商业上市；商业端以适用患者数、使用率、平均治疗时间、净价及报销为核心变量，建立实际季度数据与情景假设的桥接。若批准后公司单独披露新适应症销售或患者数据，可更新模型；在此之前不把总销售增长归因于一线 MCL。

估值讨论应以现有多适应症收入和盈利能力为底座，把潜在 MCL 增量按获批时间、区域、渗透与净价折现，并对审评延后、适用范围窄化和治疗时长下降做敏感性分析。监管节点与临床结果是催化剂，但实际价值取决于增量收入能否在毛利、销售费用及竞争影响后转化为利润和现金流。

（二）风险提示

审批与长期证据：优先审评不代表获批；监管机构可能要求补充分析、限制标签或不予批准，且 PFS 获益未必转化为 OS 改善。

安全性与竞争：持续 BTK 抑制剂暴露的感染、出血、心律失常和高血压管理及停药风险需关注；含 BTKi 免疫化疗、其他靶向组合和后续新方案可能改变一线选择，不同试验不可直接比较。

商业化与估值：药价、保险覆盖、指南更新、可及患者、治疗时长及实际渗透率可能低于假设；泽布替尼总销售还受其他适应症、汇率、竞争和研发投入影响，单一适应症催化可能已部分反映在预期中。

参考文献

[1] BeOne Medicines. BeOne Medicines Announces Third Quarter 2026 Financial Results and Business Updates[EB/OL]. (2026-11-05)[2026-11-10]. 公司公告链接.

[2] American Society of Hematology. 6 Superior progression-free survival with zanubrutinib plus rituximab vs bendamustine-rituximab in treatment-naïve mantle cell lymphoma: Primary analysis of a phase 3 study (MANGROVE)[EB/OL]. (2026)[2026-11-10]. ASH 摘要链接.

[3] BeOne Medicines. U.S. FDA Grants Priority Review to BeOne Medicines'BRUKINSA Combination in First-Line Mantle Cell Lymphoma[EB/OL]. (2026-11-04)[2026-11-10]. FDA 优先审评公告链接.

[4] U.S. Food and Drug Administration. FDA approves acalabrutinib with bendamustine and rituximab for previously untreated mantle cell lymphoma[EB/OL]. (2025-01-16)[2026-11-10]. FDA 批准公告链接.

[5] National Cancer Institute. Mantle Cell Lymphoma Treatment (PDQ®)[EB/OL]. (更新日期不详)[2026-11-10]. NCI 治疗综述链接.

[6] U.S. National Library of Medicine. Study of Zanubrutinib Plus Rituximab Compared With Bendamustine Plus Rituximab in Previously Untreated Mantle Cell Lymphoma (NCT04002297)[EB/OL]. (登记信息)[2026-11-10]. 试验登记链接.

[7] BeOne Medicines. BeOne Medicines Announces Positive Phase 3 Results for BRUKINSA in Frontline Mantle Cell Lymphoma[EB/OL]. (2026)[2026-11-10]. 研究顶线公告链接.

[8] American Society of Hematology. ASH Annual Meeting and Exposition 2026[EB/OL]. (2026)[2026-11-10]. ASH 年会信息链接.